

TEMA 3.14 • ENDOCRINOLOGÍA

Tiroiditis

PERFIL EUNACOM 1.03.2.012

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cáncer de Tiroides

Tipos y Características

TABLA 3.14.1: TIPO VS ORIGEN

TIPO	ORIGEN	FRECUENCIA	PRONÓSTICO	CARACTERÍSTICAS
Papilar	Células foliculares	~80%	Excelente (> 95% sobrevida 10 años)	Cuerpos de Psammoma, disemina por vía linfática
Folicular	Células foliculares	~15%	Bueno	Disemina por vía hematógena (hueso, pulmón)
Medular	Células parafoliculares (C)	~4%	Intermedio	Produce calcitonina ; asociado a MEN2A y MEN2B
Anaplásico	Indiferenciado	~1%	Muy malo (sobrevida < 6 meses)	Masa cervical de rápido crecimiento

- **Levotiroxina** en dosis supresivas (TSH < 0,1) → inhibir estímulo de crecimiento
- Medular/anaplásico: radioterapia ± quimioterapia

Seguimiento del Ca. Papilar y Folicular

- **Tiroglobulina** → marcador post-tiroidectomía (debe ser indetectable)
- **Ecografía cervical** periódica
- Si tiroglobulina ↑ + sin imagen → cuerpo entero con ¹³¹I

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 35 años con antecedente de cuadro respiratorio hace 2 semanas. Consulta por dolor cervical anterior que aumenta a la palpación tiroidea, con irradiación al oído. TSH 0,1 mU/L, T4 libre 2,8 ng/dL. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tiroiditis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Tiroiditis aguda: infecciosa (S. aureus), absceso unilateral, antibióticos + drenaje.
- Tiroiditis subaguda de Quervain: bocio DOLOROSO, postinfecciosa, fase hipertiroides→hipotiroides→eutiroides.
- Tratamiento de Quervain: AINEs + betabloqueo. NO metimazol. Corticoides solo si síntomas sistémicos graves.
- Captación de yodo disminuida + tiroglobulina elevada = tiroiditis subaguda (hiperliberación, no hiperproducción).
- Hashimoto: más frecuente, bocio en bolsa de gusanos, anti-TPO positivos, hipotiroidismo. Tratar con levotiroxina.
- Riedel: bocio duro/leñoso, fibrosis, muy rara. Tratamiento con corticoides.

EUNACOM CRITERIOS

Medular = calcitonina → marcador tumoral específico. Asociado a MEN2 → buscar feocromocitoma e hiperparatiroidismo.

Diagnóstico

- Ecografía tiroidea (TI-RADS 4–5 → PAAF)
- **PAAF** (punción aspiración con aguja fina) → citología
- Biopsia definitiva → post-quirúrgica

Tratamiento General

- **Tiroidectomía total** (de elección)
- **Radioyodo (¹³¹I)** post-quirúrgico → eliminar tejido residual (papilar y folicular)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TIROIDITIS)

PREGUNTA 1

Mujer de 35 años con antecedente de cuadro respiratorio hace 2 semanas. Consulta por dolor cervical anterior que aumenta a la palpación tiroidea, con irradiación al oído. TSH 0,1 mU/L, T4 libre 2,8 ng/dL. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

- A) Metimazol + propranolol
- B) AINEs + betabloqueante
- C) Prednisona de entrada
- D) Antibióticos endovenosos
- E) Levotiroxina

RESUMEN: TIROIDITIS

Las tiroiditis se clasifican en aguda (infecciosa por S. aureus/S. pyogenes, absceso unilateral, tratamiento con antibióticos + drenaje), subaguda (de Quervain/granulomatosa, postinfecciosa autoinmune, bocio doloroso con fase hipertiroides→hipotiroides→eutiroides, tratamiento con AINEs + betabloqueo, NO metimazol; corticoides solo si síntomas sistémicos intensos) y crónica. Dentro de las crónicas: Hashimoto (la más frecuente de todas, infiltración linfocitaria, bocio difuso en bolsa de gusanos, anti-TPO positivos, hipotiroidismo, tratamiento con levotiroxina si hay hipotiroidismo) y Riedel (muy rara, fibrosis tiroidea, bocio duro/leñoso, eutiroides o hipotiroides, puede comprimir estructuras cervicales, tratamiento con corticoides). La tiroiditis postparto y silente son variantes de la subaguda.